EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 68413
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2023-08-01 12:31:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: ELBA LOYOLA SOTO			**RUN**	: 3.846.219-9
F.Nac	: 20-07-1941	**Edad**	: 82 AÑOS	**Género**	: Femenino
Dirección	: FREIRE 534			**Comuna**	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	**Teléfono**	: 0		
Fecha Ingreso	: 2023-07-31	**Fecha Egreso**	: 2023-08-01 12:31:00	**Causal**	: MEDICA
Condición	: VIVO	**Destino**	: DOMICILIO	**Derivación**	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I64.X-ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO NO ESPECIF.COMO HEMORRAG

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

Diagnósticos:
- ACV territorio lenticuloestriada lateral izquierda Día 3. ATE vs embolimo
- Antecedentes: Hipertensión arterial

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I64-ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO, NO ESP.COMO HEMORRAGICO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Antecedentes:
- Hipertensión arterial. Controles irregulares, en extrasistema. Último 2020
Antecedentes quirúrgicos:
- Sin antecedentes
Alergias:
- Sin antecedentes de alergia a medicamentos
Medicamentos: desconoce, se extraen de ficha
- Escitalopram 10 mg al día
- Piascledine 1 comp al día
- Bisoprolol 2.5mg por noche
Hábitos:
- Tabaco (-)
- OH (-)
- Drogas (-)
Social:
- Vive en San Carlos con nana. 842722974

Diestra mRS0
Previamente asintomática relata haber presentado al despertar del 29/07/23 cuadro confusional asociado a hipoestesia de hemicuerpo derecho. Al intentar incorporarse, con debilidad en EEII mayor a derecha que le impide la deambulación.
Es traida al SU de HSC en que ingresa con PA 202/100 mmHg, T° 36°C, FC 56 lpm, ECG en RS, Sat 95% amb, HGT 198. No se describe examen neurológico. Se trata con Captopril 25 mg, y se solicita estudio complementario de laboratorio, sin alteraciones de relevancia y TC de encéfalo sin contraste en que se constata hipodensidad putaminal posterior izquierda de características isquémicas agudas. Se complementó estudio con angioTC de cerebro y cuello, y se hospitaliza como evento cerebrovascular. Se mantiene estable y sin fluctuación durante el ingreso.
Se toma conocimiento del caso el 31/07/23, paciente en bvuenas condiciones generales, afebril,

hemodinamia con tendencia a bradicardia leve e hipertensión. No refiere molestias. En cuanto a lo neurológico, sin fluctuación respecto al ingreso. Sin cefalea sin otras molestias. Evaluación por fonoaudiología apta para inicio de alimentación por vía oral. En cuanto a lo kinésico logra SBC bien tolerado con asistencia leve, sin fluctuación.
Se realizó ecocardiograma TT sin trombos intracavitarios. COnsiderando estabilidad neurológica, tratamiento iniciado y estudio realizado, se plantea en conjunto con familia, alta hospitalaria para seguimiento posterior ambulatorio.

PLAN DE MANEJO:

Estudio:
- Pendiente retiro de Holter e informe definitivo ecocardiograma TT.
Tratamiento:
- Mono antiagregación y estatinas.
Rehabilitación:
- Kine y fono

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo, a tolerancia. Asistido. Vigilado.
2. Régimen hiposódico liviano fraccionado lento asistido.
3. Aspirina 100 mg, 1 comp al día, vía oral.
4. Atorvastatina 40 mg, 2 comp por noche, vía oral.
5. Omeprazol 20 mg, 1 caps al día, vía oral.
6. Losartan 50 mg, 1 comp cada 12 horas, VO
7. Carvedilol 25 mg, 1/2 comp cada 12 horas, VO
8. Escitalopram 10 mg, 1 comp al día, VO
9. Pendiente entrega de Holter en unidad de cardiología HSC.
10. Kinesioterapia motora
11. Seguimiento por fonoaudiología
12. Control CAE neurología HSC
13. Control servicio de urgencias en caso de necesidad.

EXÁMENES Y RESULTADOS

Estudio complementario:
- 31/07/23 TC de encéfalo sin contraste consolidación de hipodensidad putaminal izquierda
- 31/07/23 ColT 169, HDL 35, LDL 108, TGL 129.TSH 5.51, T4L 0.74, VitB12 245. RPR (-)
- 31/07/23 Glic 123, Creat 0.6, MDRD 95.7, Uremia 37, ELP 138/3.7/105, Hb 13.8, Hto 40.0, Leuco 7700, Plaq 189.000, PCR 11.8, Lactato 0.8. P hepatico normal. INR 1.25, TTPa 29. Tropo 9.9. HbA1c 7.0
- 29/07/23 AngioTC de cerebro y cuello:
- 29/07/23 TC de encefalo sin contraste: hipodensidad putaminal izquierda posterior aguda
- 29/07/23 Glic , Creat 0.6, MDRD 95, Uremia 29, ELP 138/4.3/102, Hb 13.9, Hto 40.6, Leuco 9600, Plaq 191.000, PCR 8.4. Lactato 1.2. P Hepático normal. INR 1.12. TTPa 28. Tropo 6.5.

OBSERVACIONES:

Ex neurológico:
- Mental: Vigil, orientado en espacio, parcialmente en tiempo, inatenta, sin alteración del lenguaje, sin disartria.
- PC: pupilas isocoricas, RFM +/+, CV conservado, OCM normal sin nistagmus, hipoestesia facial derecha, disminución SNG derecho. Protruye lengua en linea media, paladar blando simétrico.
- Motor: PMP positiva prona ESD y oscila EID, hemiparesia derecha braquial M4+,crural M4+, ROT normales, plantar flexor izq, indiferente derecho.
- Sensitivo: hipoestesia 70% BC derecha
- Cerebelo: sin hallazgos
- Signos meningeos negativos.

Christian Alejandro Norambuena Aguayo
MEDICO TRATANTE
16447719-3

JEFE SERVICIO